

DIGITAL PLS OPERATING GUIDE

眼科医院 PLS 能力建设数字工作站 使用操作说明

适用于 PLS 试点医院管理层与项目团队

以及强生眼力健一线人员和内部支持团队



演示场景： 上海 Happy 卓越眼科医院

版本 演示版 2026 年 9 月

使用本说明前先了解三件事

第一，这个网站是一家医院建设 PLS 体系的数字化演示，不是全国试点医院排名或数据平台。网站以一家虚拟的“上海 Happy 卓越眼科医院”为示例，展示从认识 PLS、项目启动、流程运行到复盘认证的完整路径。

第二，Digital PLS 不是某一款 IOL 或设备的推广页面。它服务于患者需求识别、医学评估、共同决策、手术质量、岗位协作、术后管理和持续改进。产品与设备是临床工具，是否使用必须由医生根据患者情况决定。

第三，当前版本是静态演示。所有患者、指标、规格、库存和经营数据均为虚构示例。请勿录入真实患者姓名、电话、病历、检查结果或其他敏感信息。

本说明适合谁

- 医院 CEO、院长及 PLS 项目负责人：理解项目定位，组织自评，确定 90 天行动并主持复盘。
- 手术医生、验光师、特殊检查技师、护士和咨询师：围绕同一位患者完成信息与责任交接。
- HR 或培训经理：使用岗位标准、自评、学习计划和在线短测推动能力达标。
- 强生眼力健一线销售、地区经理和 PLS 团队：支持医院形成共识、识别差距、推进执行和复盘，不替代医院运营或临床决策。
- 市场、客服、运营、财务与合规人员：查阅患者教育、传播、收费、经营和合作边界相关内容。

建议先记住的主线

阶段	核心问题	网站入口	形成的输出
01 认识 PLS	PLS 到底是什么，不是什么	项目介绍 认识 PLS	CEO 共识与项目边界
02 项目启动	谁负责，MDT 如何协作	启动与自评	负责人和核心团队
03 基线自评	六大支柱和岗位能力差距在哪里	六大支柱 岗位能力	优先问题清单
04 30 天行动	先做哪三至五项工作	30 60 90 天行动	责任人 期限 验收证据
05 流程实施	各岗位如何围绕同一位患者交接	医院流程实施	可运行的患者路径
06 复盘改进	患者 团队 流程发生了什么变化	CEO 驾驶舱	问题与下一周期行动
07 固化认证	能力是否稳定 可验证 可持续	三级能力认证	SOP 运行证据 认证准备

一、 网站基本功能

网站采用“一级建设路径加二级专业工作台”的结构。一级导航帮助 CEO 和项目团队按落地顺序推进；二级页面支持临床、患者教育、岗位学习、经营测算、工具查阅和库存演示。

一级导航功能

模块	主要功能	建议使用者	典型使用时点
项目总览	查看七阶段路线 当前进度 今日工作和关键入口	全体人员	每次进入网站及项目例会前
认识 PLS	解释 PLS 含义 两条临床路径 DLS 边界 跨科组织和四项边界	CEO 医生 一线人员	首次沟通与项目启动会
启动与自评	完成六大支柱快速评估 查看 MDT 岗位标准 自评与短测	CEO 项目负责人 HR MDT	启动期和阶段复评
30 60 90 天行动	建立任务 责任人 时间和进度 连接复盘页面	项目负责人 PLS 团队	形成行动计划和周月跟进
医院流程实施	查看九段患者旅程 分流闸门 岗位交接和暂缓原因	前台 咨询师 临床团队	桌面演练和真实流程共创
复盘与改进	查看质量 团队 六大支柱 行动和经营情景	CEO LT 项目负责人	第 30 60 90 天复盘
知识与工具	检索 23 个决策 Q&A 并打开工具箱网页	全体人员	遇到问题 制定方案或培训时

二级专业工作台

工作台	可以完成什么	重要边界
临床协作工作台	查看视觉需求 IDEAL 五步 检查完整性 风险提示和医生术前摘要预览	最终诊断 适应证 IOL 型号与度数由医生确认
患者教育	演示白内障 老花 不同光学概念 Phaco FLACS 及术后困扰回应	视觉示意不能预测个人结果 不能替代医生解释
岗位学习与考试	按咨询师 验光师 技师 医生 护士等岗位自评 学习和短测	80 分是演示版本及格线 不等于正式上岗认证
三级能力认证	查看基础实践 卓越实践 卓越示范中心及八大评估模块	网站自评不会自动授予认证

工作台	可以完成什么	重要边界
经营情景测算	设置患者量 路径比例 客单结构与产能限制 观察 12 个月情景	是管理情景分析 不是财务承诺或销售指标
患者漏斗	查看同批患者在旅程各节点的推进和暂缓原因	旅程推进不等于销售转化
库存与耗材	查询演示 IOL 型号 度数及 Catalys VERITAS 耗材余量	不连接真实库存 不预留或扣减物料

二、首次进入与基本操作

打开网站

1. 使用电脑或手机浏览器打开项目方提供的网站链接。静态文件版本也可以直接打开网站文件夹中的 index.html。
2. 在登录页面输入项目管理员分配的演示用户名和密码，然后点击登录。
3. 首次进入会显示 PLS 项目介绍页。建议第一次使用时完整浏览，再点击进入 Digital PLS 工作台。
4. 进入工作台后，从顶部一级导航选择当前项目阶段。页面中的蓝色或描边按钮通常会进入二级工作台或完整说明。
5. 需要结束使用时点击顶部退出。登录状态只保留在当前浏览器标签页中。

角色选择

首页的“我的工作台”会根据所选角色显示不同的患者、任务和工具入口。角色选择用于演示工作分工，不验证真实身份，也不代表正式权限控制。

6. 在首页找到“我的工作台”或角色选择区域。
7. 选择与当前演练相符的角色，例如 CEO、医生、咨询师、护士、验光师、特殊检查技师、HR 或培训经理、PLS 团队。
8. 查看该角色当前需要关注的患者节点、行动任务和知识入口。
9. 完成讨论后切换到下一个角色，观察同一位患者的信息是否能够顺利交接。

数据保存 导出与重置

- 演示数据保存在当前浏览器本地，不会自动同步到其他电脑、手机或浏览器。
- 页面刷新后，本地演示修改通常会保留；清除浏览器数据可能使修改消失。
- 行动页面可导出演示数据，用于项目讨论或备份。导出内容仍应按演示数据管理，不要混入真实患者信息。
- 需要重新演练时可使用重置功能恢复初始演示数据。重置前先确认是否需要保留当前演练结果。

推荐设备

CEO 沟通、流程共创和多人演练建议使用电脑或会议室大屏；个人学习、Q&A 检索和岗位短测可使用手机。

浏览器缩放建议保持默认比例，避免表格和流程节点显示过小。

三、按项目阶段使用网站

阶段一 与 CEO 介绍 PLS

目标是让医院领导先理解 PLS 的医学价值、医院价值和边界，而不是立即讨论产品组合。

10. 从“项目介绍”开始，讨论患者目标为什么从视力表走向真实生活，以及医院为什么需要完整的质量闭环。
11. 进入“认识 PLS”，解释 Premium、Lens、Surgery 三个字母，并说明 PLS 不是新术式、单一 IOL、设备项目或简单的全自费销售。
12. 展示基础医保白内障路径与 PLS 优质视觉路径。强调两条路径共享安全、规范、尊重患者的医学底线，不是高低等级关系。
13. 讨论白内障科与屈光科的协作。推荐先建立跨科 PLS 服务线或虚拟中心，不把行政合并作为项目启动前提。
14. 如 CEO 质疑眼力健的项目动机，打开第 23 问。坦诚说明商业身份，同时明确不绑定 Odyssey、PureSee、Catalys 或其他指定产品。

本阶段建议输出：CEO 对 PLS 定位和合作边界的共识、医院项目负责人、参与自评的核心团队，以及下一次共创会时间。

阶段二 项目启动与基线自评

15. 进入“启动与自评”，由 CEO 或项目负责人组织六大支柱快速评估。评分应基于现状证据，不以期望状态代替真实能力。
16. 查看 MDT 岗位知识与技能标准，确认咨询师、验光师、特殊检查技师、手术医生、接待护士、手术护士和术后随访护士的责任。
17. 让岗位人员完成逐项自评和五题在线短测。80 分为演示及格线；低于 80 分时形成学习、辅导和复评计划。
18. 将六大支柱差距与岗位差距合并，选出最影响患者路径的三至五项优先问题。

本阶段建议输出：基线评估、优先问题清单、每个问题的医院责任人和需要眼力健支持的内容。

阶段三 制定 30 60 90 天行动

19. 进入行动页面，把优先问题转化为具体任务。每项任务写清责任人、完成时间和验收证据。
20. 第 1 至 30 天建立最小可运行流程；第 31 至 60 天用真实流程发现问题并修订；第 61 至 90 天形成 SOP、复评岗位能力并准备认证证据。
21. 项目启动时同步写清合作边界，包括医院主体责任、医生决策权、产品选择权、数据边界和眼力健能够及不能提供的支持。
22. 不要一次铺开所有工作。优先选择能形成患者闭环的三至五项任务。

阶段四 医院流程实施

“医院流程实施”页面以一位患者连接所有岗位。演练时不要只看页面内容，要让不同岗位分别回答“我接到什么信息、我完成什么工作、我把什么交给谁”。

患者节点	主要角色	系统中关注什么	交接结果
引流与预约	市场 客服	患者来源 初步需求 预约信息	到院信息完整
到院分流	前台 接待护士	基础信息 风险提示 分配咨询师	进入初评或医生优先复核
IDEAL 评估	咨询师	生活方式 视觉任务 戴镜意愿 顾虑	形成需求摘要
路径确认闸门	咨询师 医生	基础医学筛查和简版需求访谈	标准诊疗 PLS 深评或医生优先复核
全面检查	验光师 特检技师	检查清单 数据质量 异常升级	完整可靠的检查资料
医生诊断	手术医生	需求摘要 检查结果 风险与适应证	医生确认临床方向
方案确定	医生 咨询师	收益 局限 风险 替代方案 费用	患者理解并自主选择
手术执行	医生 手术护士	身份 眼别 IOL 手术核查	安全规范的手术记录
术后随访	随访护士 咨询师 医生	安全 恢复 视觉主诉 升级路径	随访闭环与持续改进

路径确认闸门怎么用

建议分流节点设置在完成基础医学筛查和简版 IDEAL 需求访谈之后、进入 PLS 专项检查之前。这样既减少过早按支付能力分流造成的误判，也避免所有患者都进入高成本专项流程。

- 进入标准诊疗路径：患者主要目标是安全复明，或暂不需要进一步 PLS 评估。
- 进入 PLS 深度评估：患者存在明确的高视觉需求，基础筛查未发现明显禁忌，愿意进一步了解选择。
- 医生优先复核：存在危险症状、复杂眼病、检查异常、预期不合理或其他需要临床判断的问题。

系统只提示流程方向，不自动判断医保资格、手术适应证、IOL 选择或患者支付能力。

临床协作工作台怎么用

23. 选择演示患者，查看其生活方式、重点视觉场景、戴镜偏好和主要顾虑。

24. 核对 IDEAL 五步是否完整，并检查术前检查项目是否完成。

25. 查看需医生复核的问题和结构化术前摘要预览。

26. 由医生结合完整检查确认诊断、适应证、手术策略、IOL 型号和度数。
27. 咨询师依据医生确认的方案进行患者教育，不自行做医学推荐。

阶段五 患者教育与术后支持

视觉示意

患者教育页面可以帮助患者和家属理解白内障、老花以及单焦点、双焦点、EDOF、FVR 和 Toric 等光学概念。建议先让患者描述真实生活场景，再选择相关示意，避免从产品名称开始介绍。

- 切换日间与夜间场景，帮助患者理解不同环境下的视觉关注点。
- 说明示意图是教学工具，不是个人术后效果预测，也不能比较具体产品疗效。
- 介绍 Phaco 和 FLACS 时，重点说明基本过程、患者配合和安全核查，不作绝对化优劣承诺。

光晕眩光与投诉回应

28. 先接住患者感受，确认问题对生活造成的影响，不争辩、不否认。
29. 出现突发视力下降、明显眼痛、红眼、恶心呕吐等危险信号时，立即升级给医生。
30. 对非急症主诉安排标准化医学评估，检查屈光状态、眼表、角膜、IOL 位置、后囊、黄斑和视神经等可能因素。
31. 由医生形成处理计划和复诊节点，咨询师负责解释、记录和跟进。
32. 完成病例复盘，检查术前筛查、沟通、收费、病历、手术质量和术后响应是否需要改进。

阶段六 CEO 复盘与持续改进

CEO 驾驶舱的正确顺序是先看执行和患者价值，再看规模与经营。推荐使用以下五问主持复盘：

33. 本周期实际完成了什么，而不是计划了什么？
34. 这些流程是否在真实患者和岗位中被使用？
35. 患者体验、临床质量和团队能力发生了什么变化？
36. 哪些流程仍然断开，为什么？
37. 下一周期由谁完成什么，何时复盘？

经营情景测算怎么用

进入“未来 12 个月 PLS 经营情景测算”，先判断医院属于重点建设型、培育型还是暂缓型，再设置患者基数、适配比例、选择比例、客单结构和产能约束。建议同时查看保守、基准和积极三种情景。

- 测算用于讨论人员、门诊、检查、手术和随访资源，不是业绩承诺。
- 人均 GDP 只是参考变量，应同时看患者基数、支付能力、视觉需求、医院能力和区域患者流动性。
- 收入数字不能倒逼医生扩大适应证，也不能把患者旅程转化为强制销售漏斗。

阶段七 能力固化与认证

当流程能够稳定运行后，进入三级能力认证页面，对照基础实践认证、卓越实践认证和卓越示范中心的要求准备证据。重点不是提交漂亮材料，而是证明流程确实持续运行。

- 准备 SOP、岗位职责、培训与考试记录、病例和 MDT 复盘、患者随访、投诉闭环及质量改进证据。
- 根据八大评估模块进行自查，并关注现场核查、年度复评和认证红线。
- 网站中的分数和进度只用于演示，不会自动授予任何认证。

四、不同角色如何使用

角色	最常用入口	在什么时间使用	主要任务
CEO 院长	认识 PLS 自评 CEO 驾驶舱 认证	启动会 30 60 90 天复盘	定方向 定责任 配资源 看质量和持续改进
项目负责人	项目总览 行动计划 流程实施	每日或每周推进	维护任务 协调部门 组织复盘 收集证据
手术医生	临床工作台 患者旅程 Q&A	术前决策 MDT 术后问题复核	诊断 适应证 方案确认 风险处理
咨询师	我的工作台 IDEAL 患者教育	首次咨询 方案解释 术后随访	发现需求 解释选择 确认理解 记录并升级问题
验光师 特检技师	流程实施 临床工作台 岗位能力	检查和术前准备	确保数据完整可靠 识别异常并交接
接待护士	患者旅程 我的工作台	患者到院和分流	核对信息 识别风险 交给正确岗位
手术护士	患者旅程 岗位能力 库存	术前核查和手术当天	身份眼别 IOL 核对 手术流程与耗材支持
随访护士	患者旅程 患者教育 投诉流程	术后各随访节点	发现危险信号 记录体验 触发医生复核
HR 培训经理	岗位标准 自评 短测 学习进度	基线评估 培训后复评	按能力差距安排学习 辅导和考试
PLS 团队 一线人员	项目介绍 自评 行动 Q&A 驾驶舱	拜访 共创会 周期复盘	支持诊断 共创 推进和复盘 不代替医院决策

五、 知识与工具的使用

PLS 项目决策 Q&A

当前网站完整收录 23 个项目建设问题，可按岗位、主题和关键词检索。关键问题还会出现在分流、临床、患者教育、投诉、CEO 驾驶舱和行动页面，点击后进入同一完整回答，避免不同页面出现不同口径。

- 38. 进入“知识与工具”，点击“PLS 项目决策 Q&A”。
- 39. 选择角色或类别，也可以输入关键词，例如医保、GDP、投诉、科室、动机或收费。
- 40. 先阅读简明回答，再查看管理要点、不能做什么和责任边界。
- 41. 将回答用于内部准备和共同讨论，不要机械背诵；涉及诊疗、医保、收费、税务或宣传时仍需相应责任部门复核。

工具库

工具库可站内打开医院遴选、六大支柱评估、90 天行动、视觉需求问卷、心理预期复核、术后随访等工具。工具网页是独立副本，其中填写的数据不会自动同步到网站患者档案。

- 先按当前项目阶段选择工具，不要一次把全部模板交给医院。
- 在站内预览确认内容后，再决定是否独立打开、填写、打印或用于会议。
- 正式应用前由医院完成本地化，包括岗位名称、审批流程、医学内容、品牌和合规审核。

六、 四种推荐使用场景

场景一 一线人员首次拜访 CEO

会前	会中	会后
阅读认识 PLS 和 CEO 常见 Q&A；准备医院已有信息和三个开放问题。	用项目介绍统一概念；讨论医院价值和边界；不从产品参数开始。	确认项目负责人、基线自评参与人、资料需求和下次共创时间。

场景二 医院项目启动共创会

建议时长	页面顺序	会议输出
60 至 90 分钟	认识 PLS → 六大支柱自评 → 岗位能力 → 患者旅程 → 30 天行动	三至五项优先任务、医院责任人、眼力健 支持事项、复盘日期

场景三 MDT 患者流程桌面演练

- 42. 选择一位演示患者，由市场或前台开始。
- 43. 每位角色只完成自己的步骤，并说明交接依据。
- 44. 遇到异常、信息缺失或决策边界时，使用 Q&A 或升级给医生。
- 45. 记录流程断点，转化为 30 天行动任务。

场景四 第 30 60 90 天复盘

- 46. 先看上期行动是否完成及证据。
- 47. 再看患者漏斗、暂缓原因、质量提示、患者反馈和投诉。
- 48. 复评六大支柱及岗位能力，确认变化是否真实。
- 49. 必要时使用经营情景测算讨论资源配置，但不以收入代替质量判断。
- 50. 形成下一周期行动，并确定下一次复盘时间。

七、 使用边界与信息安全

- 本网站不是 HIS、EMR、CRM、LMS、正式库存系统或医疗器械软件。
- 不得录入真实患者姓名、电话、身份证号、病历、检查结果、影像、费用或其他敏感信息。
- 网站不提供自动诊断、适应证判断、IOL 推荐、度数计算或疗效预测。页面中的 AI 辅助方案为规则化演示预览，未接入真实 AI 模型。
- 患者教育视觉示意不能预测个人术后效果，也不能代替医生面对面的个体化知情沟通。
- 登录属于静态网站的演示级访问限制。账号与校验逻辑存在前端文件中，不具备正式系统的安全强度。

- 公开 GitHub Pages 不适合承载真实患者数据。正式应用必须建设服务器端认证、分级权限、日志审计、加密存储、备份及医院系统接口。
- 医保、收费、税务、广告传播、患者授权和产品资料须由医院及公司相应责任岗位按属地规定审核。
- PLS 不绑定指定 IOL 或设备。医院是否采用 Odyssey、PureSee、Catalys 或其他技术，应由医生和医院依据患者需要、医学证据及合规流程决定。

八、常见操作问题

问题	处理建议
关闭网页后为什么要重新登录	登录状态仅保存在当前浏览器标签页，关闭标签页或退出后需要重新登录。
换一台电脑为什么看不到修改	演示数据保存在当前浏览器本地，不会跨设备同步。可使用导出功能保存讨论结果。
可以录入真实患者吗	不可以。当前版本没有正式身份权限、加密、审计和医院系统接口。
短测 80 分是否表示正式上岗	不是。80 分只是演示版本及格线，还需要医院规定的培训、带教、观察和授权。
自评完成后是否自动获得认证	不会。认证需要按标准提交运行证据并接受相应核查。
库存数字是否真实	不是。库存、IOL 度数和设备耗材均为演示数据，查询不会预留或扣减库存。
经营测算是否可以作为销售目标	不可以。它用于情景讨论和资源规划，不能影响适应证、医生判断和患者选择。
工具网页的数据为什么没有回到患者档案	工具箱中的页面是独立网页副本，当前版本尚未与网站患者档案打通。
页面内容与医院实际流程不一致怎么办	先记录差异，在共创会中完成本地化；正式使用前须经医院临床、管理和合规审核。

九、一线人员会前检查清单

- 我是否已经了解这家医院当前的白内障量、团队、流程和主要问题？
- 本次会谈处于认识 PLS、自评、行动、实施、复盘还是认证阶段？
- 我准备打开哪些页面，是否避免一次展示所有功能？
- 我要帮助医院回答的三个问题是什么？
- 哪些内容必须由医生、CEO、财务、医保或合规人员确认？

- 会议结束时是否能够形成责任人、完成时间、验收证据和复盘日期？
- 我是否清楚说明了医院主体责任、医生决策权、患者选择权和数据边界？

十、使用后的反馈

试用后建议记录四类反馈：哪些页面真正帮助了工作；哪些环节仍需重复录入或线下沟通；哪些提醒、数据或权限必须在正式系统中实现；哪些内容需要医学、合规或医院本地化审核。反馈应回到患者价值、临床安全、团队效率和持续改进，而不是只关注页面数量或功能多少。

反馈维度	建议记录	可以提供的证据	下一步
有效功能	哪个页面帮助了哪项工作	会议记录 使用场景 岗位反馈	保留并优化
流程断点	哪里仍需重复录入或线下追问	患者旅程演练 交接记录	调整流程或接口
正式系统需求	需要哪些数据 提醒 权限或审计	角色任务 数据字段 风险说明	进入需求评估
审核与本地化	哪些内容需医学 合规或医院确认	修改意见 审核人 版本日期	完成审核再使用

版本说明

本说明对应当前“眼科医院 PLS 能力建设数字工作站”演示版本。网站内容会随医院共创、临床审核、项目试运行和能力认证标准的完善持续更新。